

Fecha Última Actualización: 20-10-2022 10:31:36

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Jennifer Andrea Sepúlveda Jara
Edad : 38a 10m 16d
Dirección : Caleta Iquique 141, Block C, Depto 303

Rut : 15.708.556-5
Fecha Nacto: 04/12/1983
Comuna : Lo Prado

N° Archivo : 2220346
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 6847 3301

N° Epicrisis
327219

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 06/10/2022 19:17

Días Estadía: 14

Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Egreso : 20/10/2022 10:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda
Rut : 15708556-5
Edad : 38 años
FI HLF : 06/10/2022
FI CASR : 08/10/22
FI UCI : 10/10/2022
FI UTIM : 14/10/2022

ANTECEDENTES

MÓRBIDOS: Trastorno por uso de sustancias, múltiples veces internada

QUIRÚRGICOS: (-)

FCOS: (-)

ALERGIAS: no

HÁBITOS: tabaquismo (-). OH (+), drogas (+) PBC, THC.

INMUNIZACIONES: COVID19 x2 dosis, Anti Flu 2022 (-)

HOSPITALIZACIONES RECIENTES: (-)

SOCIAL: situación de calle. Red de apoyo madre Carmen Jara +569 77102975. Previo a su ingreso, internada en centro de rehabilitación.

HISTORIA CLÍNICA

Paciente derivada desde APS donde había consultado por cuadro de compromiso del estado general, baja de peso, tos húmeda. Realizan Serología VIH que resulta reactiva y derivan a SU del CASR.

Signos vitales de ingreso: PA 108/62 mmHg, FC 63x₂, HGT 91mg/dl, Temp 36.3°, SatO2 95% FiO2 Amb. Describen al examen físico icterica, deshidratada, lengua saburral.

Lab 06/10/22= GSV Ph 7.44/PCO2 41/ HCO3 27.7/ Leu 6360/ HB 9/ HTO 28/ PCR 45.1/ Na 136/ K 2.3/ Cl 100/ BUN 13.2/ Creat 0.5/TTPa37/INR 1.15/Bil T 18/ BIID 12.8/ FA 163/ GGT 172/TGO 98/TGP 39/Ac Úrico 2.1/LDH 308/Prot 6.2/Alb 1.5/ Lipasa 20/Amilasa 7.6.

Fecha Epicrisis : 20/10/2022 10:31

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:06

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 20-10-2022 10:31:36

Página 2 de 3

PCR COVID (-), Serologías VHB, VHC (-), PCR PCP (+) 276 copias. Sedimento urinario no inflamatorio, UC (p), PCR Gen Xpert (-), HMC₂s (p).

TC TAP 07/10/22= Foco de condensación en LM y LSI, con signos de bronquiolitis celular adyacentes y algunas opacidades parenquimatosas con densidad en vidrio esmerilado peribronquiales en lóbulos inferiores.

Hígado se encuentra levemente aumentada tamaño a expensas del lóbulo derecho, con impregnación heterogénea con el uso de medio de contraste endovenoso. No se identifican en estas condiciones lesiones focales de aspecto agresivo en su espesor. Eje venoso porto esplenomesentérico y venas suprahepáticas permeables. Vesícula biliar en repleción parcial con edema submucoso. Cálculos en su lumen de hasta 3 mm.

TC Cerebro 08/10/22= solución de continuidad a nivel parietal derecho, con imagen sugerente de hematoma subdural crónico. Importante atrofia corticocortical. No cuenta con informe formal.

Se hospitaliza con los siguientes diagnósticos:

1. Infección por VIH de Reciente Dx- Etapa Cx
 - Neumonía por PCP
 - Desnutrición Severa
 2. Compromiso de Conciencia en estudio
 3. Alteración de Pruebas Hepáticas de Patrón Mixto- Hepatocelular/ Colestásico
 - Hepatitis OH/ Maddrey Score 18.4
- AM-> Situación de calle, TUS ¿ Policonsumo (OH, PBC, THC)

EVOLUCIÓN:

HEMODINAMIA: Ingresa a UTIM hipotensa, mal perfundida, hipotérmica. Se inició manejo con volemicización, requiriendo inicio de noradrenalina en dosis de hasta 0.1 ug/kg/min. Se trasladó a la UCI donde continuó reanimación logrando suspender soporte vasoactivo el 13/10. Posteriormente sin mayor conflicto.

RESPIRATORIO: Debut de VIH con falla respiratoria atribuida a neumonía por P. jirovecii. Durante estadía en UTIM con deterioro ventilatorio progresivo que se manejó con CNAF sin éxito por lo que se intubó el 10/10/2022 y se conectó a ventilación mecánica. Buena evolución en UCI, sin grandes interurrencias en lo respiratorio, logra extubarse el 13/10/2022. Se traslada a UTIM donde desteta O2. Actualmente con adecuada mecánica ventilatoria.

INFECCIOSO: VIH de reciente diagnóstico, debut como neumonía por P. jirovecii diagnosticado por PCR en gárgaras. Se inició terapia con cotrimoxazol, corticoides y se agregó cobertura con ampicilina/sulbactam empírico, con lo cual tuvo mejoría del shock séptico y de la falla respiratoria.

Dado que ingresó con un síndrome confusional se realizó una punción lumbar el 08/10/10 con citoquímico anodino, cultivo negativo, ADA normal, VDRL no reactivo, PCRs virus herpes simplex y varicela negativas.

Se controla CV 1.050.000 y CD4 30. (P) HLA.

Con respecto a estudio de coinfecciones VHC y VHB no reactivos, Gene Xpert TBC (-), Chagas, VDRL y virus HTLV no reactivos. IgG Toxoplasma (+). Fondo de ojo sin retinitis por CMV.

Evaluada por infectología con plan de inicio de TARV en ambulatorio.

NEUROLÓGICO: Compromiso cualitativo de conciencia a su ingreso, CT de cerebro impresiona sin hallazgos agudos, PL sin hallazgos. Suplementación con Tiamina + ác. Fólico para prevención de Wernicke. CT de cerebro evaluado por neurocirugía refieren se observa craneotomía antigua con colección impresiona extradural pequeña sin efecto de masa, sin neumoencéfalo ni hallazgos de carácter agudos. Evoluciona favorablemente, resolviendo compromiso de conciencia. Al momento del traslado paciente lúcida, tranquila.

GASTRO/HEPÁTICO: Clínicamente icterica, con alteración de pruebas hepáticas mixta, con marcada elevación de bilirrubina. En TC sin dilatación de vía biliar, con colelitiasis y atenuación del parénquima hepático que podría estar en contexto de hepatitis aguda. En UCI cursó con reagudización de la alteración del perfil hepático. En ese sentido se planteó una probable hepatitis OH (que tendría un Maddrey 18) +/- DILI por cotrimoxazol. Evoluciona con descenso progresivo de p. hepáticas (Bilirrubina de 18 a 3.9) compatible con Hepatitis OH en resolución.

Fecha Epicrisis : 20/10/2022 10:31

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:06

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 20-10-2022 10:31:36

Página 3 de 3

HEMATOLÓGICO: Ingresó con anemia moderada macrocítica, sin compromiso de otras series, que se fue profundizando durante estadía en UCI sin requerir de terapia transfusional. Se estudió con TSH 0.91 y vit B12 1881. Recibiendo ácido fólico y nutriéndose con lo cual Hb 7.7 --> 8.9 g/dL.

NUTRICIONAL: Desnutrición calórico proteica severa, durante estadía en UCI con hipokalemia, hipocalcemia e hipofosfemia que se interpretaron como síndrome de realimentación, que se manejó con alimentación progresiva y reposición de electrolitos según necesidad. Ya estabilizada, con adecuada ingesta vía oral.

OFTALMOLÓGICO: Fibrosis subretinal temporal en ojo derecho obs atrofia coriorretinal antigua, con indicación de continuar controles en retina al alta.

Dado estabilidad clínica, se decide alta y control ambulatorio en centro base (Hospital San Juan de Dios).

Diagnóstico de Egreso

VIH / Sida - debut
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) - PCP (+)
ENFERMEDAD TOXICA DEL HÍGADO CON HEPATITIS AGUDA - Hepatitis OH en resolución
Desnutrición proteicocalórica, no especificada -
SÍNDROME DE DEPENDENCIA DEL ALCOHOL - Policonsumo de sustancias en rehabilitación

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

HDN estable, afebril, sin req. de O₂ suplementario.

Plan Post Alta

- Pedir hora a infectología con interconsulta a la brevedad para inicio de TARV.
- Mantener manejo de centro de rehabilitación.

MEDICAMENTOS:

- Mantener tratamiento con Cotrimoxazol forte (dosis: 2-2-1) comprimidos al día, hasta completar 14 días (hasta el 22/10). Luego tomar Cotrimoxazol forte 1 comprimido al día.
- Prednisona 20 mg al día por 10 días más (hasta el 29/10).
- Ac. fólico 5 mg al día vo
- Omeprazol 40 mg/día vo
- Quetiapina 25 mg/noche vo

Acudir al servicio de urgencia en caso de fiebre, color amarillo de piel y mucosas, compromiso de conciencia, ahogo o según necesidad.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hipoproteico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Manuela Cortazar Morriozon

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 20/10/2022 10:31

Página 3 de 3